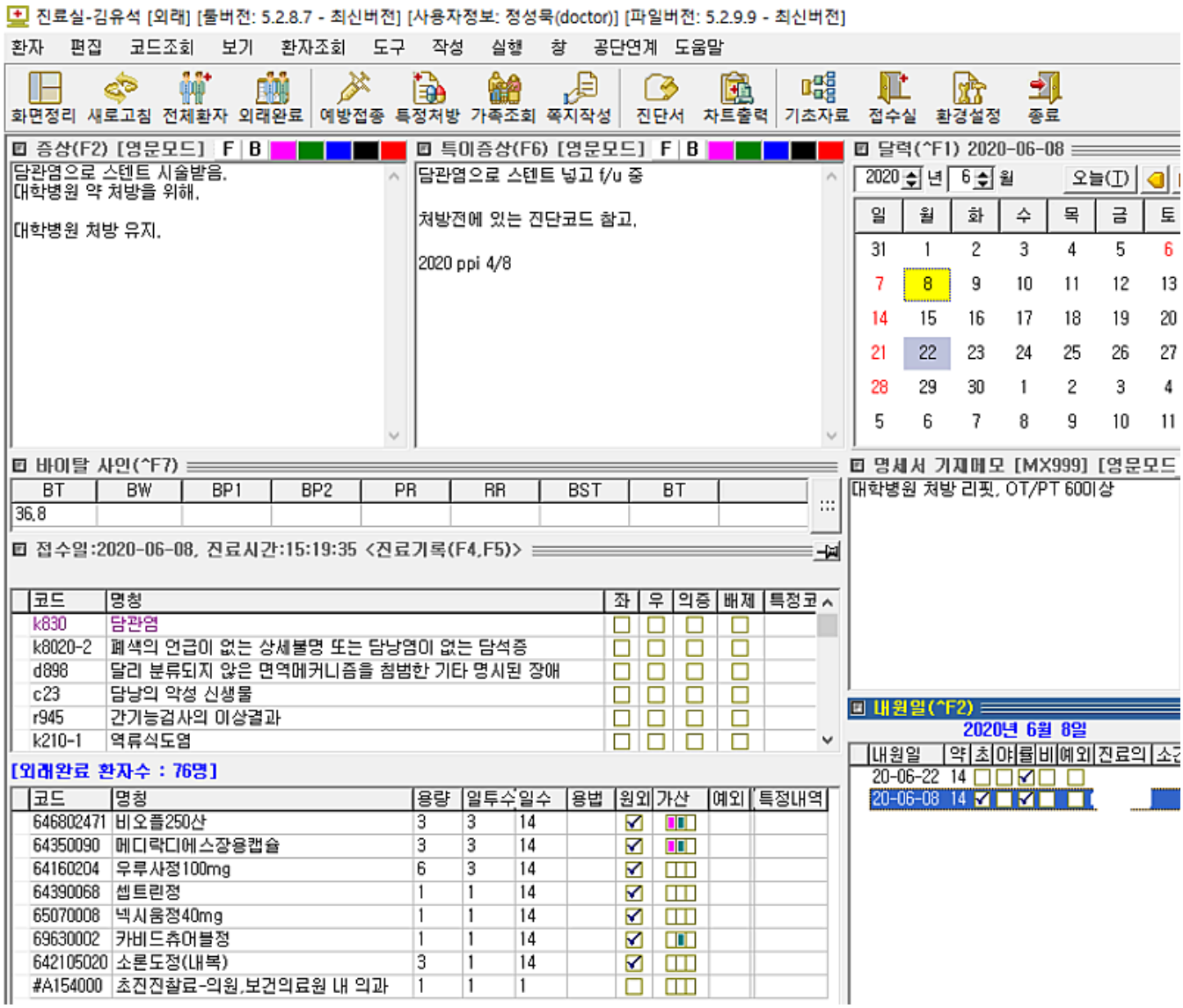
대학병원 repeat 삭감 케이스

천대표 ✓ 구독 중 1:1 채팅
2020.07.01. 15:26 조회 120

댓글 0 URL 복사



대학병원 등 타병원에서 보험으로 타던 사람들이 repeat을 요구하는 경우에 삭감이 잘 됩니다.
위에 대표적인 케이스를 보여드리며 설명하겠습니다. 경험많은 두분이 연속으로 놓친 경우라 누구든 그럴 수 있다고 생각됩니다.

1. 대학병원서 보험되면 무조건 보험?
- 아닙니다. 대학병원도 삭감된겁니다.(심평원 대답)
명세서에 권위에 호소하는 어떠한 문장을 적더라도 의미없습니다.
대학병원에서 쓴 코드를 모두 다 입력해도 의미없습니다.

2. 같은성분 2개는 100/100하면 괜찮다?
- 아닙니다. 100/100은 반만 보험같은 의미로 심평원 자료에 보이고,2개나 같은 성분약을 쓸 타당한(어떠한 약도 심평원 기준에 증명할 길 없음) 이유가 없다면 삭감됩니다.
삭감은 건강보험 공단 재정만이 아닌 환자에게 돈을 쓰게 하는 것도 해당됩니다.
따라서 위의 케이스에선 비오플,메디락에스 둘 중 하나는 F12로 했어야합니다.

3. 배수처방 삭감
- 타병원 repeat의 문제중 하나인데요. 평소 잘 쓰지 않는 약이라 배수짜리가 있는지 없는지를 몰라 배수처방 삭감가능성이 매우 높습니다.
위의 케이스는 우루사 100mg 2T/1회 처방했는데 우루사는 200mg짜리가 있으므로 명백한 배수처방삭감입니다.
1회 용량을 2로 낼땐 기초자료 라이브러리에서 2T 용량의 제형이 있는지 확인해주세요.
또한 우루사는 1년이내의 otpt 결과가 필요한데 명세서에는 정확한 날짜와 수치가 적혀있지 않으므로 배수처방 아니더라도 삭감입니다.

4. 셉트린은 효능효과 보셔서 해당 상병이 필요한데 위에 나열된 상병만으로는 커버되지 않아서 삭감입니다.

5. 넥시움40mg(PPI 고용량)은 1회최대 4주,연간최대 8주만 보험이 되므로 길게 먹을 환자는 처음부터 보험 안해주는게 좋습니다.

6. 소론도(steroid)는 코드도 알러지 등 누락되었지만,장복시 tapering등 필요하므로 장기처방은 안하는게 맞습니다.

종합적으로 위의 케이스는 모든 약이 삭감 및 한계가 있으므로 돌려보내는게 맞았습니다.

타병원 repeat은 보통 고가의 약을 장기간 처방하므로 삭감액이 큽니다.
환자가 많을때에는 일일이 찾아보는데 시간도 많이 들고요.
100% 확실하지 않은 처방은 반드시 제게 전화로 물어보세요. 그래서 자다가도,술먹다가도 전화를 멀쩡히 받으려 무던히 애를 쓰고 있습니다. 전화했다고 절대 뭐라 하거나 그런 마음조차 먹지 않습니다 ㅎㅎ

클린봇 댓글알림

유성우
댓글을 남겨보세요
등록